

FICHE D'ORIENTATION EN CONSULTATION

Identifier la phase de stress dominante

Phase 1 – Alarme (stress aigu, ponctuel)

Ressenti dominant : montée brutale de stress, crises, pics anxieux.

Signes clés

- palpitations, souffle court
- sueurs, bouffées de chaleur
- boule dans la gorge, nausées
- agitation, hypervigilance

Temporalité : récente, situation identifiable.

Question pivot : « *Est-ce récent et lié à un événement précis ?* »

Phase 2 – Résistance (je tiens mais je m'épuise)

Ressenti dominant : fatigue mentale, tension permanente.

Signes clés

- brouillard cérébral, troubles de concentration
- irritabilité, nervosité
- sommeil peu réparateur
- infections plus fréquentes

Temporalité : semaines à mois.

Question pivot : « *Est-ce que vous fonctionnez encore, mais au prix d'efforts constants ?* »

Phase 3 – Épuisement psychique

Ressenti dominant : lassitude profonde, perte d'élan.

Signes clés

- fatigue mentale intense
- démotivation, perte de confiance
- douleurs diffuses
- troubles digestifs marqués

Temporalité : mois à années.

Question pivot : « *Avez-vous l'impression que votre mental ne suit plus ?* »

Phase 4 – Épuisement psychique et physique

Ressenti dominant : rupture globale.

Signes clés

- fatigue extrême permanente
- anxiété généralisée, attaques de panique
- troubles du sommeil sévères
- dérèglements digestifs et immunitaires

Temporalité : installation longue.

Question pivot : « *Même le repos ne suffit plus ?* »

FICHE TRANSVERSALE – ANXIÉTÉ

Quand l'anxiété est au premier plan

Important : l'anxiété n'est pas une phase du stress, mais **une expression possible**, présente dans toutes les phases.

Signes dominants

- inquiétude excessive, anticipations négatives
- tension intérieure constante
- troubles digestifs fonctionnels
- besoin de contrôle, ruminations

Mécanismes dominants

- hyperactivation du système nerveux
- déséquilibre GABA / sérotonine
- hypoglycémies réactionnelles fréquentes
- digestion perturbée

Lecture clinique

- anxiété + pics → souvent phase d'alarme

- anxiété + fatigue → phase de résistance
- anxiété + effondrement → épuisement

L'anxiété **oriente la stratégie**, mais c'est la phase de stress qui détermine les priorités.

ADAPTATIONS PAR PUBLIC SPÉCIFIQUE (principes)

Femme enceinte / allaitante

- priorité absolue : sécurité, stabilité glycémique
- éviter toute stimulation des surrénales
- accent sur digestion, magnésium alimentaire, protéines

Enfants / adolescents

- lecture comportementale prioritaire (sommeil, agitation, émotions)
- éviter le discours sur le stress
- travail indirect via alimentation, rythme, digestion

Sportifs

- vigilance sur le surentraînement = facteur de résistance chronique
- besoins protéiques et minéraux accrus
- attention aux excitants et au déficit énergétique

Troubles digestifs (SII, dysbiose)

- digestion = levier central
- priorité à l'assimilation avant la correction nutritionnelle
- anxiété souvent secondaire à l'axe intestin–cerveau

Personnes sous IPP / traitements chroniques

- vigilance sur les carences (Mg, B12, fer)

- digestion affaiblie = aggravation du stress
 - travail progressif et non stimulant
-

Logique d'utilisation en consultation

1. Identifier la phase dominante
2. Repérer si l'anxiété est centrale ou secondaire
3. Adapter la fiche phase + ajustements spécifiques au terrain

Cette grille permet une **lecture rapide, sécurisante et cohérente** pour le consultant.